

Depression (Unipolare depressive Störung)

Definition:

Affektive Störung mit dem Leitsymptom einer gedrückten Stimmung, verbunden mit vermindertem Antrieb und Freudlosigkeit. Die unipolare Depression macht ca. 65% aller affektiven Störungen aus. Eine Klassifikation erfolgt nach Schweregrad (leicht, mittelgradig, schwer) sowie dem zeitlichen Verlauf (monophasisch, rezidivierend, chronisch). Eine Chronifizierung ist möglich.

Epidemiologie:

- **Lebenszeitprävalenz**
 - Allgemeinbevölkerung: 16–20%
 - Verwandte 1. Grades einer erkrankten Person: Bis zu 30%
 - Konkordanzrate bei eineiigen Zwillingen: Ca. 50%
- **Jahresprävalenz (Stand 2014)**
 - Allgemeinbevölkerung: Ca. 8%
 - Erhöht bei Personen in sozial schwachen Schichten, in städtischem Wohnumfeld und ohne enge soziale Beziehungsstrukturen
- **Erstmanifestation**
 - In ca. 50% der Fälle vor dem 31. Lebensjahr
 - Nach dem 60. Lebensjahr selten (10% der Fälle)
 - Bei Frauen früher als bei Männern
- **Geschlechterverteilung:** ■ > ■ (2:1)

Ätiologie:

Es wird von einem komplexen **Vulnerabilitäts-Stress-Modell** ausgegangen. Genetische, neurobiologische und psychosoziale Faktoren wirken zusammen.

- **Genetische Faktoren:**
 - Bekannte familiäre Häufung
 - Vulnerabilität wird vererbt, keine spezifischen Gene bekannt
- **Neurobiologische Aspekte:**
 - **Monoaminmangelhypothese:** Relatives Defizit von Noradrenalin, Serotonin und Dopamin; gestützt durch Wirkweise der Antidepressiva
 - **Cholinerg-aminerge Imbalance-Hypothese:** Relatives cholinerges Übergewicht bei Depression; relatives aminerges Übergewicht bei Manie
 - **Glutamat-Hypothese:** Überaktivität des glutamatergen Systems; gestützt durch antidepressive Wirkung von Ketamin
 - **Neurotrophin-Hypothese:** Defizit an neurotrophen Faktoren (BDNF); Hippocampusatrophie bei depressiv Erkrankten
 - Erhöhte Cortisolwerte: Konstitutionell gesteigerter HHN-Achse, Dysregulation bei Depression und PTBS
 - Verändertes Schlafmuster: Verlängerte Einschlaf latenz, verkürzte REM-Latenz, verlängerte erste REM-Phase, Reduktion des Tiefschlafs
- **Psychische Faktoren:**
 - **Kognitive Triade (nach Beck):** Negativ verzerrte Sicht auf sich selbst, die Welt und die Zukunft
 - **Erlernete Hilflosigkeit (nach Seligman):** In subjektiv unkontrollierbarer Situation erlebte Hilflosigkeit wird auf nachfolgende Situationen übertragen
 - **Verstärkerverlust:** Verlust positiver Verstärkerquellen durch äußere Einwirkung oder Reduktion positiv verstärkender Verhaltensweisen
 - **Psychodynamisch:** Störung in früher Entwicklungsphase führt zu unsicherem Selbstwertgefühl und ungünstiger Konfliktlösung

- **Psychosoziale Faktoren:**

- Kindheitserfahrungen: Verlust-/Trennungserlebnisse, Mangel emotionaler Zuwendung
- Interpersonelle Faktoren: Störungen sozialer Beziehungen, Fehlen enger sozialer Strukturen
- Soziales Umfeld: Niedriger sozialer Status, städtisches Wohnumfeld

Prognose:

- Leichte/mittelgradige Episode: Ambulante Behandlung in der Regel möglich
- Auf eine erfolgreiche Akuttherapie (6–12 Wochen) sollte eine Erhaltungstherapie folgen → senkt Rückfallrisiko um ca. 70%
- Rezidivprophylaxe bei ≥ 2 depressiven Episoden in den vergangenen 5 Jahren empfohlen (Pharmako- oder Psychotherapie über mind. 2 Jahre)
- Chronifizierungsrisiko besteht, insb. bei fehlender oder unzureichender Behandlung
- Hohe Komorbidität mit anderen psychiatrischen Erkrankungen (ca. 60%), insb. Angststörungen, Substanzabhängigkeit, Persönlichkeitsstörungen

Merke: Suizidalität ist eine ernste Komplikation der Depression und muss aktiv erfragt und engmaschig überwacht werden!

Symptome:

Symptombdauer mind. 2 Wochen. Einteilung nach Schweregrad:

- **Hauptsymptome (mind. 2 von 3 müssen vorliegen):**

- Gedrückte Stimmung (ggf. als Gefühl der Gefühllosigkeit)
- Freud- oder Interessenverlust an normalerweise angenehmen Aktivitäten
- Verminderter Antrieb oder gesteigerte Ermüdbarkeit

- **Zusatzsymptome:**

- Schlafstörungen jeder Art
- Unbegründete Selbstvorwürfe oder ausgeprägte Schuldgefühle
- Verlust des Selbstvertrauens oder des Selbstwertgefühls
- Wiederkehrende Gedanken an Tod oder Suizid
- Appetitverlust oder gesteigerter Appetit mit Gewichtsveränderung
- Vermindertes Denk- oder Konzentrationsvermögen, Unschlüssigkeit
- Psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit

- **Psychotische Symptome** (nur bei schwerer depressiver Episode nach ICD-10, bei ICD-11 auch mittelgradig):

- Depressiver Stupor
- Halluzinationen
- Wahnideen (i.d.R. synthymmer Wahn): Schuldwahn, hypochondrischer Wahn, nihilistischer Wahn, Verarmungswahn

- **Somatisches Syndrom** (mind. 4 der folgenden Symptome):

- Deutlicher Interessens- oder Freudverlust (Anhedonie)
- Mangelnde Reagibilität, Früherwachen, Morgentief
- Psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit
- Deutlicher Appetitverlust, Gewichtsverlust $\geq 5\%$ im letzten Monat
- Deutlicher Libidoverlust

- **Komorbiditäten:**

- Psychisch: Angststörungen, Zwangsstörungen, Substanzabhängigkeit, Persönlichkeitsstörungen, somatoforme Störungen
- Somatisch: KHK, Diabetes mellitus, Parkinson-Syndrom, Demenz, Tumorerkrankungen, Schlaganfall

Merke: Schwere depressive Episoden gehen i.d.R. mit einem somatischen Syndrom einher!

Diagnostik:

Diagnostische Kriterien nach ICD-10:

- **Kriterium A – Allgemeine Kriterien:** Dauer der depressiven Episode mind. 2 Wochen; keine anamnestischen (hypo-)manischen Symptome; Ausschluss von Substanzmissbrauch oder organischer Ursache.
- **Kriterium B – Hauptsymptome** (mind. 2 von 3 müssen erfüllt sein): Gedrückte Stimmung; Freud-/Interessenverlust; verminderter Antrieb oder Ermüdbarkeit.
- **Kriterium C – Zusatzsymptome:** Verlust des Selbstvertrauens; Schuldgefühle; Suizidgedanken; Konzentrationsstörungen; Psychomotorik verändert; Schlafstörungen; Appetitveränderungen.
- **Kriterium D – Psychotische Symptome:** Gilt nur bei schwerer depressiver Episode: depressiver Stupor, Halluzinationen oder Wahnideen.

Schweregradeinteilung nach ICD-10:

- **Leichte depressive Episode (F32.0):** Alle Kriterien A, mind. 2 aus B, 1–3 aus C
- **Mittelgradige depressive Episode (F32.1):** Alle Kriterien A, mind. 2 aus B, 3–5 aus C
- **Schwere depressive Episode (F32.2):** Alle Kriterien A, alle 3 aus B, mind. 5 aus C
- **Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen (F32.3):** Kriterien der schweren Episode + Kriterium D

Screeningverfahren:

- **Zwei-Fragen-Test:** Freudverlust und Niedergeschlagenheit im letzten Monat erfragen
- **PHQ-9:** Selbstbeurteilungsverfahren mit 9 Items; Hinweis auf mind. mittelgradige Symptomatik bei ≥ 5 bejahten Items
- **WHO-5-Fragebogen:** Einschätzung des Wohlbefindens der letzten 2 Wochen, 0–5 Punkte pro Aussage

Fremdbeurteilungsskalen zur Verlaufskontrolle:

- **HAMD (17-Item):** ≤ 8 = Remission; 9–16 = leicht; 17–24 = mittelgradig; ≥ 25 = schwer
- **MADRS:** ≤ 6 = Remission; 7–19 = leicht; 20–34 = mittelgradig; ≥ 35 = schwer
- **BDI-II:** < 14 = Remission; 14–19 = leicht; 20–28 = mittelgradig; ≥ 29 = schwer

Therapie:

Allgemein: Abhängig vom Schweregrad; Kombination aus Pharmako- und Psychotherapie bei schwerer Episode, chronischem/rezidivierendem Verlauf und unzureichender Wirksamkeit einer Monotherapie. Ausführliche Psychoedukation zu Beginn.

Psychotherapie:

- **Beste Datenlage für:** Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) und Interpersonelle Psychotherapie (IPT)
- **Weitere störungsspezifische Verfahren:**
 - Psychodynamische Psychotherapie
 - Gesprächspsychotherapie
 - CBASP (bei chronischer Depression, ≥ 3 Episoden)
 - ACT, MBCT, Behavioral Activation (Verhaltenstherapie dritte Welle)
- Im Vergleich zu Pharmakotherapie: Längere Wirklatenz, aber Hinweise auf länger anhaltenden Therapieeffekt, niedrigere Rückfallrate und bessere Adhärenz

Pharmakotherapie:

- Einsatz immer im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes; Ziel ist eine Monotherapie
- **Wirkstoffgruppen der 1. Wahl:**
 - SSRI (z.B. Citalopram, Sertralin, Fluoxetin)
 - SSNRI (z.B. Venlafaxin, Duloxetin)
 - NaSSA (z.B. Mirtazapin)
- **Weitere Optionen:** SNDRI (Bupropion), Trizyklika (z.B. Trimipramin), MAO-Hemmer (z.B. Moclobemid), Agomelatin, Trazodon, Esketamin-Nasenspray

- **Auswahl des Antidepressivums nach:** Nebenwirkungsprofil, Komorbiditäten, Patientenpräferenz, Alter, Toxizität und Erfahrungen aus Vortherapie
- **Beginn:** Niedrige Dosierung (3 Tage), dann zügige Steigerung bis Standarddosis; wöchentliches Monitoring in den ersten 4 Wochen
- **Wirksamkeitsbeurteilung:**
 - Non-Response: Reduktion $\leq 25\%$
 - Partielle Response: Reduktion 26–49%
 - Response: Reduktion $\geq 50\%$
 - Remission: Weitestgehende Symptombefreiheit
- **Bei unzureichender Response:** Augmentation (Lithium, atypische Antipsychotika), Wechsel des Antidepressivums oder Kombination von Antidepressiva

Nicht-medikamentöse somatische Therapieverfahren:

- **Elektrokonvulsionstherapie (EKT):** Wirksamkeit 80–90% (unbehandelt), 50–75% (therapieresistent); indiziert bei schwerer therapieresistenter Depression, depressivem Stupor und akuter Suizidalität
- **Repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS):** Bei therapieresistenter Depression; geringere Wirksamkeit als EKT
- **Schlafentzugstherapie (Wachtherapie):** Rascher Wirkungseintritt; positive Effekte in ca. 60% der Fälle; antidepressiver Effekt i.d.R. nicht anhaltend; zur Überbrückung der Wirklatenz von Antidepressiva
- **Lichttherapie:** Insb. bei saisonaler Depression; 10.000 Lux, weißes Licht ohne UV-Anteil; täglich 30–120 min; Response-Rate 60–90%
- **Weitere Maßnahmen:** Strukturierter Sport (möglichst im Gruppensetting), Entspannungsverfahren, Ergotherapie, Soziotherapie

Merke: Schwere depressive Episoden erfordern stationäre Behandlung, insb. bei Suizidalität, depressivem Stupor, psychotischen Symptomen oder starker psychosozialer Belastung!